

-LA SECURITE
SOCIALE ET
SYSTÈME DE SOINS
EN ALGERIE

Introduction à la protection sociale

1/ La sécurité sociale: est un système de protection sociale vise à partager aux travailleurs et leur famille contre les conséquences des risques sociaux

/ Les autres acteurs de la protection sociale:

1) l'Etat par le biais du Ministère de l'Action Sociale

2) la Solidarité nationale



Types des risques sociaux:

La maladie, maternité, l'invalidité, les accidents du travail, les maladies professionnelles, le décès, le chômage, la vieillesse et les charges familiales



Prévoyance:

Protéger les personnes contre les coups de la vie Maladie, Retraite, chômage

La protection sociale : est l'ensemble des mécanismes, fondés sur l'idée d'une solidarité nationale entre les personnes qui assurent les ressources aux individus= (types de risques sociaux)

- Elle répond à la SECURITE.
- Elle a une ambition capitale :protéger tout la population et catégorie sociale.
- Elle a un idéal noble :assure la même protection à chacun.

les logiques de système de protection sociale

1 Une logique d'assurance: Se fait par l'assurance collective obligatoire

Les **prestations** فوائد dépendent des **cotisations** مساهمات préalablement versées

2 Une logique d'assistance;

ce fait par l'assistance collective et obligatoire entre individus et destinée aux **gens démunis**

Les aides accordées à ces personnes le sont, **sans contrepartie**. La société doit porter secours aux pauvres, vieillards ou enfants abandonnés.

La gestion des risques sociaux

Assurée par des caisses à compétence nationales

des retraites (1.5 millions de personnes)

d'AssuranceChômage pour les jeunes chômeurs .

1983 : refonte du système de la sécurité sociale

Les ambitions

Unification des régimes (instauration d'un régime unique)

Unicité de gestion.

Uniformisation des cotisations et des avantages de sécurité sociale

cad : assurer toute la population Contre tous les risques (sauf chômage) par une seule caisses

Les formes de la protection sociale

La sécurité sociale : institutions chargés de gérer la protection sociale. « Gérer », de la protection sociale (prelever des cotisations obligatoires pour aider des individus qu'ont des situations particulières (maladie,, chômage, etc.).

L'aide sociale : les prestations versées à des personnes connaissant des difficultés spécifiques Ils sont appréciées par une commission spécialisée.et les aides sont versées par condition

L'action sociale : les prestations ne sont pas obligatoires Il sont versées par certains organismes afin d'améliorer la vie des individus.C une action volontaire

LES TYPES DE PRESTATIONS SOCIALES...

Une prestation sociale,

est un versement destiné à une personne qui se trouve dans une situation particulière

pension de retraite

allocation chômage

remboursement maladie,

pension de retraite,

pension d'invalidité,

en
espèces

soigné à l'hôpital

les crèches SAMU

en
nature

Le régime général

1-lois de 1983; de conditions pour l'ouverture du droit à la retraite.

2-Etre âgé de 60 ans au moins, (la femme travailleuse peut prétendre à la retraite à partir de l'âge de 55 ans.)

3-Avoir travaillé 15 ans au moins (valable pour l'homme _ femme)

4-Avoir accompli un travail effectif et avoir versé les cotisations au titre de la sécurité sociale durant une période égale à au moins la moitié de la durée de travail sus indiquée.

Force de la protection sociale= SOLIDARITE NATIONALE

Entre les Régimes.

Entre malades et biens portants. Entre actifs et retraités.

Entre célibataires et chargés de famille

Ce qu'a permis la protection sociale

- ☐ *Une espérance de vie à la naissance de 74 ans
- ☐ *Un taux de mortalité en baisse
- ☐ *Une espérance de vie après 60 ans (12 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes)
- ☐ *De lutter contre la pauvreté des personnes âgées

L'organisation du système:

18

Les différents couvertures

Les acteurs chargés de la couverture

La couverture de base



La sécurité sociale



Le régime assurance chômage

La couverture complémentaire



La Mutualité



Les régimes complémentaires de retraites



Les institutions de prévoyance



Les compagnies d'assurance à but lucratif

• L'aide sociale



L'ETAT



Les collectivités locales Et wilayales Communes

Le rôle de l'État

1 Pas gestionnaire de l'ensemble du système de soins mais il l'intègre dans sa politique économique et sociale.

2 Détermine la politique de santé par la loi, mais ne maîtrise pas l'exécution de sa politique

3 N'assume pas obligatoirement les conséquences de ses choix tout en étant responsable des comptes de la sécurité sociale.

4 Fournisseur de soins via le secteur hospitalier sans maîtrise de l'ensemble

5 C'est la CNAS qui gère d'où importance de son Conseil d'Administration et des Administrateurs désignés par les organisations Syndicales.

CONSTAT

Augmentation des dépenses de santé indéniable :

Développement technologique

Nouvelles pathologies

Evolution démographique

amélioration des conditions de vie et de prise en charge sanitaire

effets du vieillissement par le biais du développement des maladies chroniques

revalorisation des honoraires de médecins PUBLIQUES-

CONSTAT

21

Augmentation des dépenses de santé indéniable :

□ Développement technologique

□ Nouvelles pathologies

□ Evolution démographique

□

amélioration des conditions de vie et de prise en charge sanitaire

□

effets du vieillissement par le biais du développement des maladies chroniques

□

revalorisation des honoraires de médecins PUBLIQUES-

Sécurité sociale = solidarité nationale

Régime général : 80 % des dépenses Financement :
cotisations sociales

Régime complémentaire : à la charge des assurés

☐ Ne pas pénaliser
les entreprises

☐ Ne pas diminuer trop
le pouvoir d'achat des
ménages pour ne pas
freiner la
consommation

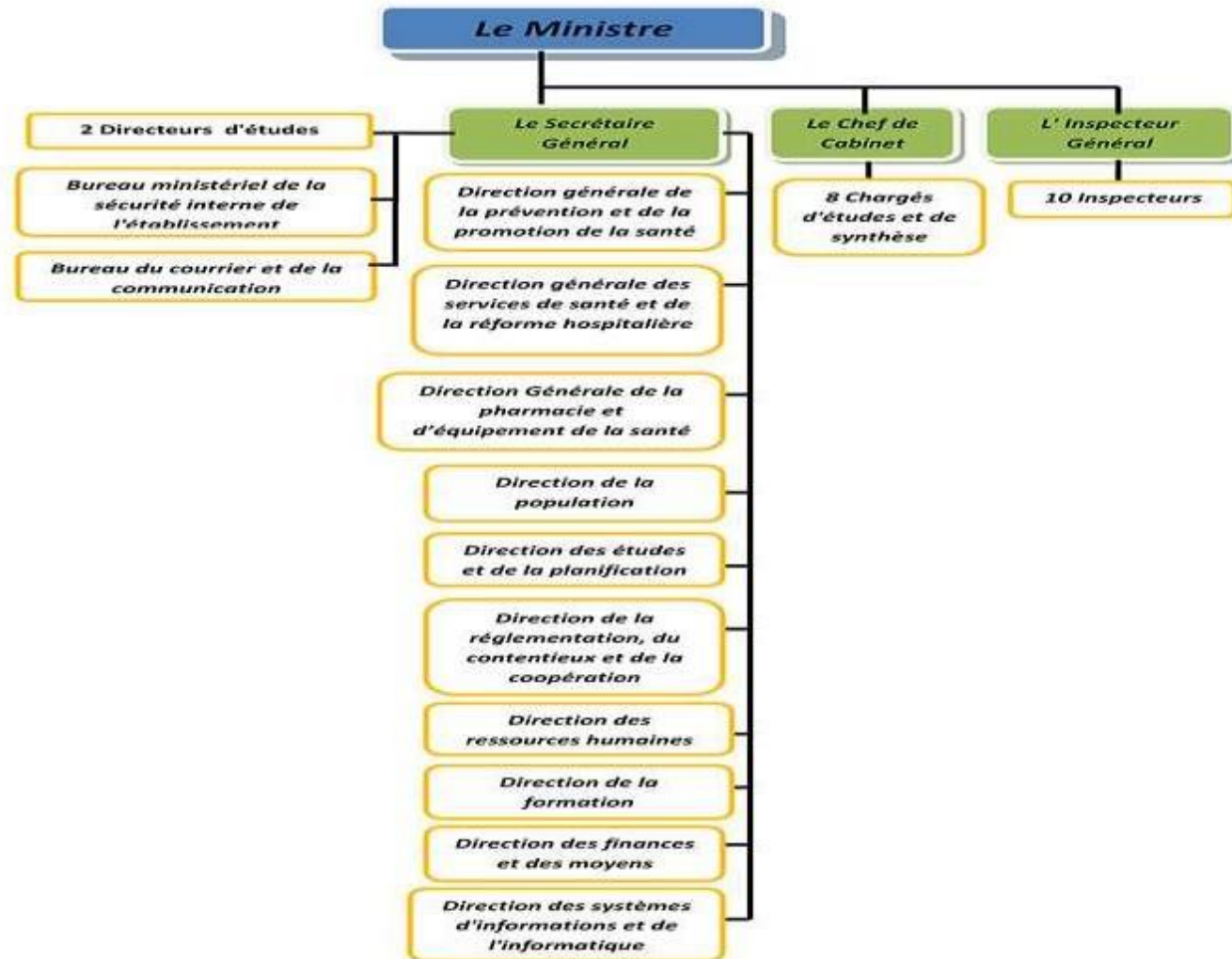
☐ Ne pas laisser le
déficit s'accroître pour
ne pas augmenter
l'endettement

☐ Trouver d'autres
sources de
financement

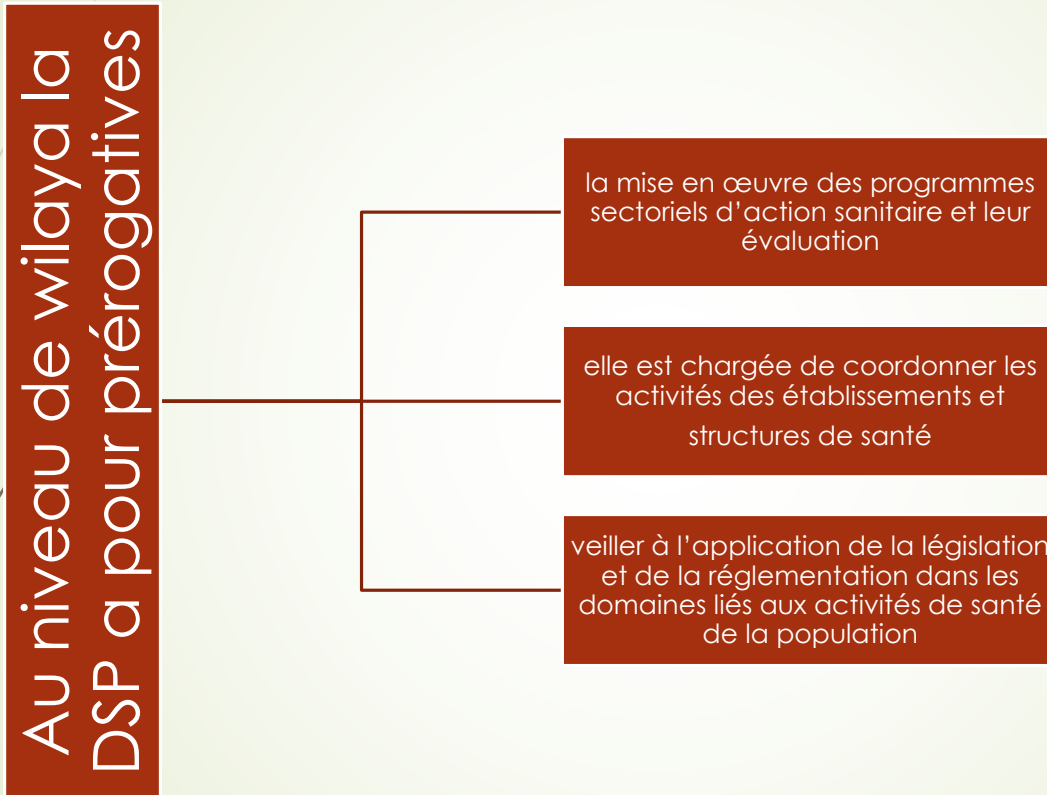
■ Système nationale de soins

- Ensemble des activités et des moyens destinés à assurer les soins de santé de la population.
- Son organisation est conçue afin de prendre en charge les besoins de la population en matière de santé de manière globale, cohérente et unifiée dans le cadre de la carte sanitaire.
- Ce système est basé sur le renforcement du secteur public afin d'assurer un développement réel de la gratuité des soins .il est piloté par l'Etat, au niveau national ,régional et wilayale.

Organigramme du ministère de la santé



Organigramme décentralisé et déconcentré



11 Structures de soutien : INSP , IPA, PCH, ANS, ENSP, LNCCP, ANDS, INFPF, CNT, CNPM, ANGREGS (Agence Nationale de Gestion des Réalisations et des Equipements des Etablissements de Santé) .

DEFINITION OMS DE LA QUALITE DE SOINS

La qualité des soins est définie par l'OMS(منظمة الصحة العالمية) comme

- la délivrance à chaque patient de l'assortiment d'actes diagnostiques et thérapeutiques
- qui lui **assurera le meilleur résultat en terme de santé,**
- conformément à l'état actuel de la science médicale,
- au meilleur coût pour un même résultat,
- au moindre risque iatrogène
- et pour sa plus grande satisfaction en terme de procédures, de résultats et de contacts humains à l'intérieur du système de soins.

Quatre dimensions de la qualité des soins

Les capacités relationnelles du médecin ou du soignant sont capitales et intègrent **l'écoute, le tact, l'empathie, la sensibilité, la confidentialité, mais aussi l'information du patient sur sa maladie et la prise en charge proposée.**

- **Le lien relationnel entre le patient et son médecin** permet la confiance qui conditionne l'adhésion future du patient à la stratégie de soins proposée.
- **Les installations et équipements** . Ils doivent assurer aux patients un certain confort, et respecter l'intimité et la confidentialité.
- **Les soins mis en œuvre par le patient et son entourage** . La compliance du patient aux soins est fondamentale pour la réussite du traitement.
- **Les soins reçus par la communauté** correspondant aux soins reçus par l'ensemble de la communauté, avec l'accessibilité, la garantie du même niveau de qualité des soins pour tous.

Facteurs clés de succès

1 l'implication de la direction ;

2 la prise en compte du temps nécessaire à la mise en place d'une démarche qualité ;

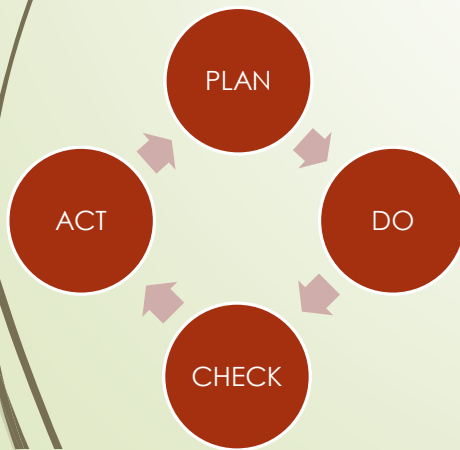
3 l'implication des personnels ;

4 la formalisation des procédures qui doit favoriser le travail des acteurs et non l'inverse ;

5 la communication ;

6 le fait que la qualité correspond à un état d'esprit.

L'amélioration continue de la qualité = schéma de Deming



prévoir ;

mettre en œuvre ;

mesurer et contrôler ;

réagir et améliorer.

La qualité des soins

La qualité des soins = la mesure dans laquelle les services de santé destinés aux individus et aux populations augmentent la probabilité de parvenir à l'état de santé souhaité

*5,7 à 8,4 millions de décès annuels dans les pays à revenu faible/moyen dus à des soins de santé de mauvaise qualité.

*Elle dépend de connaissances professionnelles fondées sur des bases factuelles et est essentielle pour instaurer la couverture sanitaire universelle.

*il faut examiner la qualité des soins et des services de santé qu'ils devraient être
Efficaces=reposer sur des bases factuelles et être
dispensés à ceux qui en ont besoin ;
sûrs= éviter de porter préjudice à ceux qui en bénéficient

Les bénéfices de soins de qualité

dispensés en temps utile,

Équitables= la qualité des soins ne doit pas varier en fonction du genre, de l'origine ethnique, de la situation géographique et du statut socioéconomique ;

Intégrés=l'ensemble de services de santé doivent être disponibles à toutes les étapes de la vie ;

efficacients,= les ressources disponibles doivent être exploitées au maximum en évitant le gaspillage.

Organisation des soins

Ce système repose sur ses composantes et leurs interrelations .

Il est conçu et analysé en fonction de ses objectifs:

- *amélioration de la santé des populations,
- *Équité et capacité de répondre aux attentes légitimes des populations,

Il est aussi la base des fonctions qu'il doit assumer :

la délivrance de services de soins personnels (soins médicaux, soins infirmiers, aide aux personnes, ...)

Délivrance de services appartenant au domaine de la santé publique, et autres fonctions principales que sont:

- l'administration ,
- le financement,
- Les ressources humaines .

la distribution des soins comporte des activités de prestation de soins préventifs et curatifs dirigés vers toutes les structures sociales

Infrastructures sanitaires

La prise en charge de manière intégrée et hiérarchisée des problèmes de santé de la population est assurée au niveau de différentes structures de santé

: EPSP (**Etablissement Public de Santé de Proximité**) , polycliniques et centres de santé. **EPSP : 271 (140,80,51)**

Polycliniques : 1614 dont 637 assurent une garde H24 (939,476,199)

Salles de soins : 5414

Maternités intégrées à une polyclinique : 412 (3082 lits) **Maternités intégrées à une salle de soins**: 11 (45 lits) **Maternités autonomes**: 29 (780 lits)

PMI : 1421 dans les polycliniques & 1550 dans salles de soins

Centres d'hémodialyse : 12 (7,2,3)

SLTMR: 241

CISM : 180

CIST : 38

Services de médecine du travail : 238

SEMEP : 272

Unités de cytopathologie et de dépistage du cancer du col : 150 Unités de dépistage du cancer du sein fixes et mobiles.

PMI par EPSP au niveau des 3 régions du

Sud du pays

PMI dans polycliniques : 193

PMI dans salle de soins : 160

pays Nord du pas (Tell)

PMI dans polycliniques : 803

PMI dans salle de soins : 1027

Hauts Plateaux

PMI dans polycliniques : 425

PMI dans salle de soins : 363

Infrastructures sanitaires privés

La prise en charge de manière intégrée et hiérarchisée des problèmes de santé de la population est assurée au niveau de différentes structures de santé public et privé :

Cabinets privés :

Spécialistes : 6920 dont 1777 à Alger (cabinet de groupe 335 groupe 335)

Généralistes : 6455

■ Dentaire: 5290 (dont 241 spécialistes)

Pharmacie: 7876

Laboratoires d'analyses biologiques : 540 Centre d'hémodialyse privé:

■ Région Nord(Tell) : 100 (88 secteur public)

■ Région Hauts Plateaux : 22 (49 secteur public)

Capacité hospitalière

Les établissements hospitaliers publics

CHU et EHU : 15 (14 098 lits)

EHS : 74 (12 470 lits)

- EHS Psychiatrie
- EHS Mère-enfant +++
 - CAC
- EHS ophtalmologie
- EHS Rééducation
- EHS Chirurgie cardiaque
- EHS pédiatrique
- EHS Brûlés
- EHS urologie/néphrologie

65900 lits → 1 lit / 576 hab.
1 lit / 538 hab.

EPH : 195 (38 252 lits) EH : 5 (1080 lits)

Etablissements Hospitaliers Privés : 169 (4690 lits)

Wilayas dépourvues
d'EHP :

- Adrar, Bechar , Illizi, Tindouf, Tam,
- El Bayadh, Laghouat, Naâma, Tissemsilt
- Relizane, El Tarf, Ain Temouchent ,

Professionnelles de soins

Développement des personnels de santé préoccupation majeure du MSPRH pour:

- Assurer une couverture sanitaire équilibrée dans l'ensemble du pays
- Planifier la formation, d'après les profils requis ;
- Connaître les besoins selon des normes préalablement fixées.

Ressources humaines :

MSPRH: 297.360 fonctionnaires (3^{ème} employeur de l'état)

- Professeurs : 703 (233 F)
- Maitres de conférence A: 250 (107 F)
- Maitres de conférence B: 217(196F)
- Maitres-assistants: 2830 (1477 F)
- Résidents :10161
- Médecins spécialistes Secteur public : 14737
- Médecins spécialistes secteur libéral : 6920
- Médecins généralistes secteur public : 25604
- Chirurgiens dentistes : 7391
- Pharmaciens : 1116
- Paramédicaux : 130682
- Administratifs : 61189 dont 3000 gestionnaires
- .



Total praticiens H-U:
4000

1Med/550 hab.

**1paramédical/290
hab.**

Organisation des soins et hiérarchisation de la distribution des soins

Soins de 1^{er} recours (soins de proximité)

au niveau des quartiers urbains et communes a pour support les structures extrahospitalières : polycliniques, salles de soins , cabinets médicaux et dentaires privés;

Le paquet minimum de soins est constitué de soins de santé de base :

consultations médicales , , soins dentaires, soins pour la mère et l'enfant , soins infirmiers,explorations , éducation sanitaire, activités de prévention, urgences de premier recours

Soins de 2^{ème} recours (hospitalisation)

Il s'agit de soins généraux donnés au niveau des EPH de daïra

1^{er} niveau = EPH de Daïra ou inter-Daïra :

disciplines disponibles (minima) : médecine interne , pédiatrie, UMC, imagerie médicale, unité dentaire ,chirurgie générale, obstétrique, laboratoire biologie, pharmacie.

2^{ème} niveau = EPH de wilaya:

disciplines disponibles : anesthésie-réa, cardiologie, hématologie, orthopédie, neurologie, neurochirurgie, gynéco-obstétrique, rhumatologie, chirurgie infantile, néphrologie, ORL , ophtalmologie, psychiatrie, pneumologie, néonatalogie, anatomie pathologique, médecine légale, **oncologie médicale**, épidémiologie, endocrinologie,

Soins de 3^{ème} recours : pôle régional =EHS,EH ,EHU,CHU

Il s'agit de soins spécialisés ou hautement spécialisés mis en place pour la wilaya ou régionale

Chirurgie cardiaque, chirurgie plastique, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire, urologie, médecine nucléaire, grands brûlés, immunologie, gastro-entérologie CAC, médecine nucléaire, radiothérapie

Iatrogénie ou événement indésirable associé aux soins:

Trouble ou maladie
consécutifs à la prise d'un
médicament ou à un
traitement médical



Les événements indésirables
associés aux soins (EIAS) sont
l'ensemble des dysfonctionnements
– des erreurs – qui impactent
négativement le parcours du
patient, d'une erreur d'identité,
d'un accident médicamenteux...

Ensemble des conséquences
néfastes pour la santé, potentielles
ou avérées, résultant de
l'intervention médicale (erreurs de
diagnostic, prévention ou
prescription inadaptée,
complications d'un acte
thérapeutique) ou de recours aux
soins ou de l'utilisation d'un produit
de santé

Diagnostic d'un événement iatrogène

Signes non spécifiques, lien causal difficile à établir=>diagnostic probabiliste

40 Il faut considérer 3 notions

gravité (=>mort, risque vital, hospitalisation, prolongation d'hospitalisation, handicap ou incapacité)

-évitabilité «est un événement qui ne serait pas survenu si les soins avaient été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante au moment de la survenue de l'événement.

Différent de l'aléa thérapeutique qui correspond aux risques inhérents à l'acte médical.

-acceptabilité renvoie à la perception sociale (défaut d'information, alternatives moins risquées, rapport

Facteurs influençant la iatrogène:

Fréquence du recours au soins Fragilité des personnes

soignées Type d'acte médical

Qualité des pratiques professionnelles et comportement des professionnels

Qualité de l'organisation (la majorité des erreurs individuelles sont liées au système

Comportement du patient (observance, participation)

Sécurité de l'environnement de l'acte médical

Facteur de risque majeur est le Professionnel

42

gestes et traitements inutiles
(ex:transfusion)

non appréciation du rapport
bénéfice/risque (ex:anesthésie,
geste opératoire lourd)

non respect des protocoles
notamment des règles
d'hygiène et d'asepsie, et tout
ce que cela implique comme
conséquence (prolongation de
la durée d'hospitalisation,
infections nosocomiales)

La prévention et la diminution du risque iatrogène:

-Mettre en place une
Surveillance /
Vigilance / Veille des
événements
indésirables par: Un
signalement
spontanée par les
professionnels et
recherche active des
erreurs et événements
dans les services.

-Rédiger ou actualiser
des protocoles.

-Organiser des
réunions
d'information.

-Organiser la
formation continue du
personnel

Normalisation en santé

Pourquoi y a-t-il des normes?

-Des normes reconnues à l'échelle mondiale aident les systèmes de santé à:

élaborer et à évaluer d'importants aspects, comme la gouvernance, le leadership, la prévention et le contrôle des infections et la gestion des médicaments, qui ont tous un effet sur la qualité des services offerts au public.

Une **norme** est un document d'application volontaire, établi par consensus et approuvé par un organisme de **normalisation** reconnu qui donne des lignes directrices applicables aux activités pour application répétée et continue.

La normalisation dans le secteur de la santé:

Le secteur de la santé n'échappe pas au processus de normalisation. À la différence d'autres secteurs toutefois, il se caractérise par l'aléa (Évènement imprévisible).

Il est soumis à une évolution permanente des connaissances et des moyens diagnostiques et thérapeutiques.

Cette situation est au fondement du concept d'*evidence-based medicine* (EBM) ou médecine fondée sur les preuves : il s'agit d'appuyer les décisions cliniques sur les données les plus probantes

Objectifs de la normalisation en santé:

évaluer les médicaments, dispositifs médicaux et actes ;

évaluer et recommander les bonnes pratiques professionnelles et élaborer des recommandations de santé publique ;

mesurer et améliorer la qualité dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Les normes mondiales aident les prestataires de services de santé à faire ce qui suit :

Évaluer et améliorer la qualité de leurs services de santé

Déterminer quels types de soins devraient être offerts et cibler les

lacunes en matière de soins dans leurs systèmes actuels

Améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail

Repérer les meilleures pratiques de soins mondiales qui permettent d'offrir des services de santé fiables et de plus grande qualité au public dans les administrations locales

Déterminer l'efficience

Les normes mondiales aident le public à faire ce qui suit :

46



Savoir quel niveau de qualité
demander à leurs prestataires
de services de santé

puisqu'elles donnent aux
décideurs accès aux
meilleures données
probantes et connaissances
spécialisées disponibles, ce
qui est essentiel au processus
décisionnel.

Les normes de santé
mondiales sont aussi utiles
aux gouvernements,

les usagers peuvent voir les organisations de santé de leur localité
travailler activement à l'amélioration des soins

Donner activement de la
rétroaction au sujet de la
prestation actuelle des
services de santé et aider à
cibler les lacunes

Être certain que les services
de santé qu'il reçoit sont
normalisés, c'est-à-dire qu'ils
sont vérifiés, sécuritaires et
fiables

Donner un visage humain aux
services de santé;

Merci